

TEMA 3.20 • OBSTETRICIA

Placenta Previa Asintomática

PERFIL EUNACOM 2.01.2.015

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Placenta Previa Asintomática

Definición

Placenta que cubre el **orificio cervical interno (OCI)**. Hallazgo ecográfico sin metrorragia.

NOTA CLÍNICA

Los términos "placenta previa parcial" y "placenta previa marginal" son **obsoletos**. Solo se usan dos conceptos: - **Placenta previa** → cubre el OCI → cesárea - **Placenta de inserción baja** → < 2 cm del OCI → parto vaginal

Diagnóstico Definitivo

- **Ecografía a las 32 semanas** (diagnóstico definitivo)
- Antes de las 32 sem: alto porcentaje resuelve espontáneamente (el útero crece y eleva la placenta)
- Si se diagnostica antes de las 32 sem → **controles ecográficos periódicos** hasta confirmar o descartar

Manejo

Placenta previa confirmada (cubre OCI)

TABLA 3.20.1: SITUACIÓN VS CONDUCTA	
SITUACIÓN	CONDUCTA
Asintomática al término	Cesárea electiva a las 37 semanas (algunos a las 36 sem)
Sangrado con < 34 sem + estable	Hospitalizar + corticoides antenatales + vigilancia
Sangrado abundante o sufrimiento fetal	Cesárea urgente independiente de la EG

Corticoides antenatales siempre indicados (riesgo de prematuréz).

Placenta de inserción baja (< 2 cm del OCI, no cubre)

- **Parto vaginal posible**
- Si borde < 1 cm del OCI: riesgo relativo de sangrado intrapartum → discutir con paciente; si sangra → cesárea

Resumen Rápido

TABLA 3.20.2: DISTANCIA BORDE PLACENTARIO AL OCI VS VÍA DE PARTO	
DISTANCIA BORDE PLACENTARIO AL OCI	VÍA DE PARTO
Cubre OCI (placenta previa)	Cesárea (indicación absoluta)
0–1,9 cm (inserción baja)	Vaginal (con mayor vigilancia)

| ≥ 2 cm | Vaginal sin restricciones especiales |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Respecto a Placenta Previa Asintomática, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Placenta Previa Asintomática. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Definición
- Diagnóstico Definitivo
- Manejo
- Placenta previa confirmada (cubre OCI)
- Placenta de inserción baja (< 2 cm del OCI, no cubre)
- orificio cervical interno (OCI)
- . Solo se usan dos conceptos: -

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PLACENTA PREVIA ASINTOMÁTICA)**PREGUNTA 1**

Respecto a Placenta Previa Asintomática, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A)** El diagnóstico de Placenta Previa Asintomática se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Placenta Previa Asintomática debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Placenta Previa Asintomática requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Placenta Previa Asintomática es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Placenta Previa Asintomática no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Placenta Previa Asintomática?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Placenta Previa Asintomática. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: PLACENTA PREVIA ASINTOMÁTICA

:::note Los términos "placenta previa parcial" y "placenta previa marginal" son obsoletos. Solo se usan dos conceptos: :::